

# RETATRUTIDA (Triple Agonista GIP / GLP-1 / Glucagón)

GUÍA INTEGRAL DE PRODUCTO, MECANISMO DE ACCIÓN, DOSIFICACIÓN Y MANUAL PASO A PASO PARA PRINCIPIANTES

## 1. INTRODUCCIÓN Y FUNCIONES PRINCIPALES

La **Retatrutida** es el péptido de última generación más avanzado para el control metabólico y la pérdida de peso corporal. A diferencia de las terapias anteriores monoterapéuticas o bi-agonistas (como Tirzepatida o Semaglutida), la Retatrutida actúa como un **triple agonista de receptores peptídicos** (GIP, GLP-1 y Glucagón).

Esta sinergia de triple acción produce una potente regulación del apetito junto con un aumento directo del gasto energético en reposo.

**Beneficios y Funciones Clave:**

- **Reducción Acelerada del Tejido Adiposo:** Potente quema de grasa visceral y subcutánea.
- **Supresión Efectiva del Apetito y Ansiedad:** Retarda el vaciamiento gástrico y reduce los antojos alimenticios a nivel central.
- **Activación del Gasto Energético:** A través del receptor de Glucagón, estimula la termogénesis y la lipólisis en el hígado y tejido graso.
- **Mejora de la Sensibilidad a la Insulina:** Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y combate la resistencia a la insulina.

## 2. PRINCIPIO Y MECANISMO DE ACCIÓN

La Retatrutida activa tres vías hormonales clave simultáneamente:

1. **Receptor GLP-1:** Inhibe las señales de hambre en el cerebro y ralentiza la digestión, generando saciedad prolongada con porciones pequeñas.
2. **Receptor GIP:** Mejora la respuesta insulínica tras las comidas, optimiza el almacenamiento metabólico y reduce la inflamación tisular.
3. **Receptor de Glucagón:** Incrementa la tasa metabólica basal y promueve la movilización de ácidos grasos como fuente de energía primaria.

## 3. GUÍA DE RECONSTITUCIÓN PASO A PASO (MEZCLA CON AGUA BAC)

Para preparar su vial de polvo liofilizado de forma higiénica y conservar la eficacia del péptido:

- 1 **Desinfección:** Limpie el tapón de goma del vial de Retatrutida y del vial de Agua Bacteriostática (BAC) con una toallita con alcohol.
- 2 **Extracción del Agua BAC:** Utilizando una jeringa limpia, extraiga exactamente **1 mL (100 Unidades en la jeringa de insulina)** o **2 mL (200 Unidades)** de Agua BAC según el volumen del vial.
- 3 **Inyección Suave:** Inserte la aguja en el vial de Retatrutida apuntando hacia la pared de vidrio interna. Inyecte el agua de forma lenta. **NUNCA lance el agua directamente sobre el polvo a presión.**
- 4 **Disolución:** Mueva el vial suavemente en círculos entre sus manos. **NO agite el vial bruscamente.**
- 5 **Almacenamiento:** Una vez mezclado, conserve el vial en el refrigerador (entre 2°C y 8°C). No congelar.

## 4. TIPO DE AGUJA Y MEDICIÓN EN JERINGA PARA PRINCIPIANTES

**Tipo de Aguja Sugerida:** Jeringa de Insulina estándar de **1 mL (100 Unidades / UI)** con aguja integrada (calibre 30G o 31G de 5/16").

#### Fórmula de Conversión Fácil (Reconstituido con 1 mL de Agua BAC):

- Vial de **5 mg** + 1 mL de agua BAC  $\rightarrow$  Cada **2 Unidades (2 rayitas) = 0.1 mg (100 mcg)** | 1 mg = 20 Unidades.
- Vial de **10 mg** + 1 mL de agua BAC  $\rightarrow$  Cada **1 Unidad (1 rayita) = 0.1 mg (100 mcg)** | 1 mg = 10 Unidades.

## 5. DOSIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN POR SKU (PRESENTACIONES DEL CATÁLOGO)

A continuación se detallan las instrucciones para cada presentación disponible en la lista de productos:

| SKU  | PRESENTACIÓN                    | RECONSTITUCIÓN SUGERIDA                                | DOSIS SEMANAL RECOMENDADA                                                                                                                           | EXTRACCIÓN EN JERINGA DE INSULINA (1 ML / 100 UI)                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT5  | 1 Vial de 5 mg<br>(5,000 mcg)   | 1 mL de Agua BAC                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inicio (Sem 1-4): <b>1 mg a 2 mg/</b> semana</li><li>• Mantenimiento: <b>2.5 mg a 4 mg/semana</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dosis 1 mg = <b>20 Unidades</b></li><li>• Dosis 2 mg = <b>40 Unidades</b></li><li>• Dosis 2.5 mg = <b>50 Unidades</b></li></ul>                       |
| RT10 | 1 Vial de 10 mg<br>(10,000 mcg) | 1 mL de Agua BAC<br>(o 2 mL si prefiere mayor volumen) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Escalada: <b>2 mg a 4 mg/</b> semana</li><li>• Avanzada: <b>4 mg a 6 mg/</b> semana</li></ul>               | (Con 1 mL de Agua BAC): <ul style="list-style-type: none"><li>• Dosis 2 mg = <b>20 Unidades</b></li><li>• Dosis 4 mg = <b>40 Unidades</b></li><li>• Dosis 6 mg = <b>60 Unidades</b></li></ul> |

## 6. ESQUEMA DE ESCALAMIENTO PROGRESIVO (PROTOCOLO RECOMENDADO)

Para minimizar efectos secundarios digestivos y permitir la adaptación del organismo, se recomienda seguir un esquema de titulación gradual:

- **Semanas 1 a 4:** 1 mg a 2 mg una vez por semana (Dosis de adaptación).
- **Semanas 5 a 8:** 2.5 mg a 4 mg una vez por semana (Dosis terapéutica estándar).
- **Semana 9 en adelante (según evaluación):** 4 mg a 6 mg una vez por semana (Solo si se requiere mayor respuesta metabólica).

## 7. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios son de leve a moderados y disminuyen progresivamente con el uso continuo:

- **Gastrointestinales:** Náuseas leves, saciedad rápida, reflujo, estreñimiento o diarrea leve en los primeros días.
- **Sensibilidad Cutánea (Alodinia transitoria):** Sensación de mayor sensibilidad en la piel al tacto.
- **Disminución de Energía Inicial:** Ligero cansancio en las primeras semanas debido a la reducción drástica de ingesta calórica.
- **Sensación de Leve Aceleración Cardíaca:** Ligero incremento transitorio de la frecuencia cardíaca en reposo.

## 8. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

#### RECOMENDACIONES NUTRICIONALES Y DE APLICACIÓN:

- Administrar mediante **inyección subcutánea** (abdomen, muslo o parte posterior del brazo) **una vez a la semana**, el mismo día de cada semana.
- Mantenga un aporte adecuado de **proteínas** diarios y una correcta **hidratación con electrolitos** para preservar la masa muscular durante la pérdida de peso.

- **Contraindicaciones:** No utilizar en personas con antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides, síndrome NEM 2, o pancreatitis.
- **Rotación de Sitio:** Rote el punto de inyección cada semana para evitar irritaciones locales en la piel.